

# Prostatectomía simple

WARWIKI

Información para el paciente · Cirugía para una próstata muy agrandada (HPB)

La prostatectomía simple es una cirugía para un **agrandamiento de la próstata muy grande (HPB)** que bloquea el flujo de orina. El cirujano extrae la parte interna voluminosa de la próstata — la que causa la obstrucción — a través del abdomen, de forma abierta o con cirugía robótica/laparoscópica. Es muy eficaz en glándulas grandes.

## Una diferencia importante

La prostatectomía “simple” **no** es lo mismo que la prostatectomía “radical” para el **cáncer** de próstata. La operación radical extrae toda la próstata para tratar el cáncer. La prostatectomía **simple** extrae solo el tejido interno agrandado (benigno) y deja la capa externa — trata el **bloqueo por agrandamiento no canceroso**.

## Cuándo se usa

- Para **próstatas muy grandes** poco aptas para un procedimiento con cistoscopio (RTUP)
- Sobre todo cuando hay también **cálculos en la vejiga** o grandes bolsas vesicales que tratar
- Las opciones con cistoscopio para glándulas grandes (**HoLEP, Aquablation**) son alternativas — su cirujano le indicará cuál le conviene

## APRENDA LOS TÉRMINOS

### Prostatectomía simple

Extraer la próstata interna agrandada por HPB (no por cáncer).

### Adenoma

El tejido prostático interno benigno que se extrae.

### Prostatectomía radical

Otra operación que extrae toda la próstata por cáncer.

### Abierta vs. robótica

Por una incisión, o por pequeñas incisiones laparoscópicas.

### Eyacuación retrógrada

Orgasmo seco — un efecto común después.

### Sonda

Un tubo que drena la vejiga durante varios días después.

**¿LE DOLERÁ?** Se hace con anestesia general, así que no siente nada durante la cirugía. Como es una operación abdominal, la recuperación es **más larga que con cistoscopia** — espere unos días en el hospital (menos con cirugía robótica), una sonda por varios días y unas semanas de actividad limitada.

## Cómo prepararse

- Se hace con **anestesia general** — siga las instrucciones de ayuno y de medicamentos (suspenda los anticoagulantes según le indiquen).
- Un **análisis de orina** para descartar infección primero.
- No fume; organice un transporte y ayuda en casa.

## Qué sucede y después

- 1 Está dormido; se administran antibióticos.
- 2 Por vía abdominal (abierta) o robótica/laparoscópica, se extrae la próstata interna voluminosa y se deja la capa externa.
- 3 Se coloca una sonda (y a veces un drenaje); la estancia es de unos días (menos con robótica).
- 4 La sonda suele permanecer **varios días a una semana**.

Espere orina con sangre al inicio; **evite levantar peso y hacer esfuerzo** por varias semanas.

## Qué esperar después

- Una mejora fuerte y duradera del flujo de orina.
- La **eyaculación retrógrada** (orgasmo seco) es común; los efectos serios en las erecciones o el control de la orina son poco frecuentes.

### Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- **No puede orinar** tras retirar la sonda
- **Sangrado abundante o coágulos**, o fiebre/escalofríos
- Dolor abdominal que empeora, o enrojecimiento/secreción de la herida
- Dolor en el pecho, dificultad para respirar o una pierna hinchada y dolorosa (emergencia)

## TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La prostatectomía simple extrae la próstata interna voluminosa por HPB muy grande — **no** es la operación del cáncer (que extrae toda la próstata).
2. Es muy eficaz en glándulas grandes; la recuperación es más larga que con cistoscopia (HoLEP/Aquablation son alternativas con cistoscopia).
3. Espere eyaculación seca y una sonda por varios días. Llame si no puede orinar, hay sangrado abundante o fiebre.